

МОЗ України
КЗ ЛОР «ЛОПАБ»
Золочівська ПАЛ
м. Золочів вул. Академіка Павлова 48
Код ЄДРПОУ 20851881

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО 208 51881
Медична документація форма № 013/0

ПРОТОКОЛ

патологоанатомічного дослідження № 51/2022.

« 06 » 12 . 2022 року

Адреса закладу, де проводилося патологоанатомічне дослідження: м. Золочів, вул. Академіка Павлова 48
Держава – Україна Місто – Золочів

Лікарня Золочівська ЦРЛ. Відділення ВАІТ. Карта хворого № 3021.

1. П., і., б. Пшенична Зорина Володимирівна.

2. Стать жіноча. 3. Дата народження 05.08.1979р.

4. Адреса обл Миколаївська, м Миколаїв, вул. Дмитрієва 12, 13.

5. Професія не працює.

6. Дата поступлення в лікарню 29.11.22р.

7. Проведено ліжко-дні 6.

8. Дата смерті 05.12.22р.

9. Дата секції 06.12.22р.

10. Присутні на розтині ..

11. Діагноз закладу який направив ..

12. Діагноз при госпіталізації ХХН-Б. Анемія. Дилатаційна кардіоміопатія.

13. Клінічний діагноз у стаціонарі Гострий панкреатит. Хронічний панкреатит

K86.1 Хронічний гепатит С ХЗН 5 ст. Дилатаційна міокардіопатія.

ЗАКЛЮЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ДІАГНОЗ

Хронічна хвороба нирок, стадія 5 N18.5

Хронічний вірусний гепатит С B18.2

Дилатаційна кардіоміопатія, СН II Б ст зниженою систолічною функцією (ФВ 20%)
I50.0

Анемія при хронічних хворобах D63

Токсична енцефалопатія G92

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ

- А. Гострий геморагічний панкреатит: масивні крововиливи та гнійне запалення строми підшлункової залози.
Б. Хронічний дифузний фібропластичний гломерулонефрит: дифузний склероз та гіаліноз клубочків; дистрофічні та атрофічні зміни каналців нирок.
- Вторинно зморщені нирки (маса – 45 г, 50 г). Нефрогенна артеріальна гіпертензія; ексцентрична гіпертрофія міокарда лівого шлуночка (маса серця – 460 гр., товщина стінки лівого шлуночка – 1,9 см, товщина стінки правого шлуночка – 0,4 см). Хронічна ниркова недостатність (клінічно), корегована сеансами програмного гемодіалізу. Уремія: креатинін – 0,24 ммоль/л, сечовина – 14,5 ммоль/л.; двобічна субтотальна серозно-геморагічна пневмонія, серозно-фібринозний перикардит, інтерстиційний міокардит, ерозивна гастроентеропатія. Вторинна гіпопластична анемія (Hb – 70 г/л, еритроцити – $2,81 \times 10^{12}$ г/л). Малокрів'я та альтеративні зміни внутрішніх органів.
Набряк набухання головного мозку.

ПОМИЛКИ КЛІНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ (підкреслити)
РОЗБІЖНІСТЬ ДІАГНОЗІВ: - за основним захворюванням ЗАПІЗНІЛА ДІАГНОСТИКА

- за ускладненням
- основного захворювання
- за супутнім захворюванням
- смертельного ускладнення

ПРИЧИНИ РОЗБІЖНОСТЕЙ ДІАГНОЗІВ (підкреслити)

- об'єктивні труднощі діагностики
- рідкісне захворювання
- короткотривале перебування в стаціонарі
- неправильне оформлення клінічного діагнозу
- недообстеження хворого

ПРИЧИНА СМЕРТІ

Лікарське свідоцтво про смерть № 51 /2022:

Код за I. а) поліорганна недостатність

МКХ-10 б) набряк головного мозку

K85.0 в) панкреатит

II.

КЛІНІКО-ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ЕПІКРИЗ

На секції 43 річної жінки було виявлено поєднані захворювання: гострий геморагічний панкреатит та хронічний фібропластичний гломерулонефрит, що призвели до важкої поліорганної недостатності яка і стала безпосередньою причиною смерті.

Лікар-патологоанатом Золочівської ПАЛ Шумінський Є. Р.

підпис

Начальник КЗ ЛОР «ЛЮПАБ» РІБУН Б. Й.

підпис

20 12 22р